



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA TAHUNAN PONEK
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3, Mondoroko, Singosari - Malang

Telp. 0341 - 458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



LAPORAN KINERJA TAHUNAN RS PRIMA HUSADA MALANG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum/Latar belakang

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015. Terjadi penurunan AKI di Indonesia dari 390 pada tahun 1991 menjadi 305 pada tahun 2015. Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Indikator angkakematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA).

Angka kematian anak dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan AKN sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam rangka upaya percepatan penurunan AKI dan AKB maka pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program EMAS berupaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal melalui : 1) meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONEK dan 300 Puskesmas/Balikesmas PONEK) dan 2) memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit (Kemenkes, 2017).

Rumah sakit PONEK 24 Jam merupakan bagian dari sistem rujukan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia perlu dilakukan pembekalan melalui standarisasi pelayanan yang ditetapkan di Rumah Sakit melalui pembuatan pedoman. Pedoman pelayanan PONEK ini merupakan pedoman untuk melaksanakan kebijakan pelayanan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada Malang yang tercakup dalam ruang lingkup dan batasan operasional



1.2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor:200.50/DPM/I-KEP/DIR/II/2022 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang periode 2021-2023;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan di Unit Ponek serta mengutamakan keselamatan pasien.

1.3.2 Tujuan

1. Tercapainya kerja ruang Ponek sesuai target yang ditetapkan
2. Meningkatnya kualitas dan mutu ruang Ponek
3. Supaya petugas mempunyai jadwal yang jelas dan terarah



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan pasien dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 Motto

Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adii
7. Peduli

[illegible]

dr. Aida Musyarofah Sp. OG

Siti Zaimah Amd.Keb

1. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp.An
2. dr.Dicky, Sp.A. M biomed
3. dr. Isrotul Annisa
4. dr. Annishafira
5. Triasih, Amd.Keb
6. Elok Oktviana Amd.Keb
7. Rismaya Felantriardianti S.Kep.Ns
8. Leny Puji Rahayu Amd.Keb
9. Anita Sari S.Kep.Ns
10. Nining Tri Sari,Amd.Keb
11. Dwinta Widya Navita,Amd.Kep

BAB III.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 SDM :

3.1.1 Ketenagaan Tim Ponek Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Ketenagaan Tim Ponek Tahun 2025

Jabatan	Jumlah SDM												
	Standar	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Ketua Tim Ponek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretaris Tim Ponek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anggota Tim Ponek	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Analisa	Jumlah Tim PONEK secara keseluruhan adalah berjumlah 11 orang. Masing - masing anggota memegang jabatan yang berbeda.
Rencana Tindak lanjut	Koordinasi dengan Tim PONEK untuk mengembangkan pelayanan. Serta melakukan Diklat terkait kegawat daruratan maternal Neonatal.

3.1.2 Orientasi Tim Ponek Tahun 2025

Tabel 3.1.2 Orientasi Tim Ponek Tahun 2025

No	Nama Peserta	Tanggal Masuk	Pembelajaran Yang diterima	Hasil Evaluasi orientasi KHUSUS PONEK							
				Pengetahuan regulasi	Praktek keterampilan	7 nilai budi utama/					
						J	T	V	D	K	A P
	0										

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Tabel 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tim Ponek 2025

NO	Tema DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	JUMLAH PESERTA		TGL Pelaksanaan	Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
			Hadir	Tidak Hadir		
1.	Diklat Ponek Maternal “ Eklamsi & HPP”	Internal	11	0	15 Juli 2025	Staf mampu melakukan penangana awal kegawatan maternal Eklamsi dan HPP
2.	Diklat Kegawat Daruratan Neonatal	Internal	11	0	7.2.2025	Staf mampu melakukan penangana awal kegawatan Neonatal
3.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien	Internal	11	0	13-14 Mei 2025	Staf mampu memahami standart Mutu RS
4.	Diklat PPI	Internal	11	0	21 -22 Mei 2025	Staf mampu melakukan Standart PPI yang benar di RS



5.	BHD	Internal	11	0	10-12 September 2025	Staf mampu melakukan penanganan awal kegawatan pasien
6.	Diklat Pengolahan Limbah B3 MFK	Internal	11	0	7.7.2025	Staf mampu melakukan penanganan tumpaham B3
7.	Diklat Drill Emergency Maternal & Neonatal	Internal	11	0	24.4.2025 26.7. 2025 26.7 2025	Staf mampu melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan
8.	Penggunaan APAR	Internal	11	0	09-10 Juni 2025	Staf mampu memahami cara penggunaan APAR
9.	Keluarga berencana	Internal	11	0	28 Juli 2025	Staf mampu melakukan pemasangan KB pasca lahir
10.	Medication Error	Internal	11	0	19 Agustus 2025	Staf mampu memahami Medication error dengan baik
11.	PPGDON	Ekster nal	2	0	24-27 Februari 2025	Staf mampu melakukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif

3.1.4. Evaluasi Kinerja Tim Ponek RSPHM Tahun 2025
Tabel 3.1.4 Evaluasi Kinerja Tim Ponek RSPHM Tahun 2025

Jumlah staf	penilaian Kinerja	catatan Khusus		Hasil Evaluasi			Kesimpulan
		baik	jelek	A	B	C	
12	Umum	12 org	0 org	12			
		100 %	0%	12			
	profesional	12 org	0 org	12			
		100%	0%	12			
	tupoksi mutu di unit	PJ mutu di unit sudah melakukan penginputan sesuai mutu masing-masing					

Analisis :

- 1. Secara keseluruhan tim sudah bisa melakukan penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal
- 2. Tim sudah melakukan pencatatan pelaporan dengan baik

RTL :

- 1. Peningkatan Kompetensi PPA dengan mengadakan diklat Maternal dan Neonatal
- 2. Peningkatan Dokumentasi dan Pelaporan

3.2. Pengembangan Pelayanan

Tahun 2025 Ponek tidak ada pengembangan pelayanan

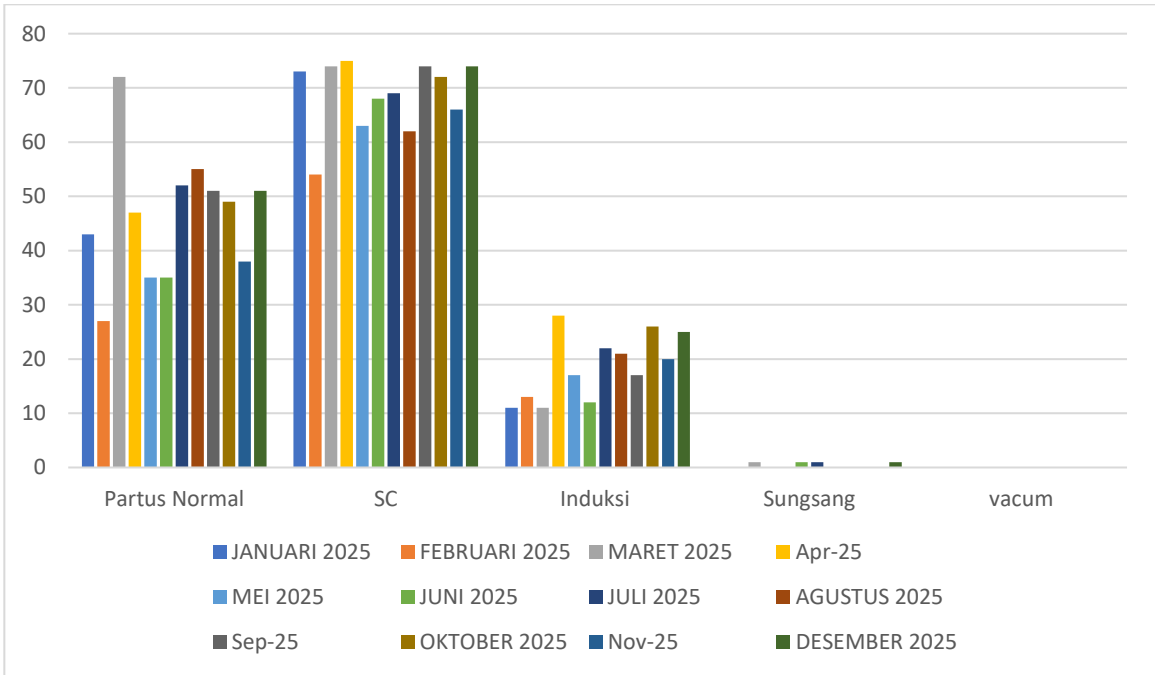
3.3. Kinerja Produktifitas Tim Ponek Tahun 2025

3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal

Tabel 3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien												Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1														
	a. Persalinan Normal	43	27	72	47	35	35	52	55	51	49	38	51	555
	b. SectioCaesaria	73	54	74	75	63	68	69	62	74	72	66	74	824
2														
	a. Induksi / Drip	11	13	11	28	17	12	22	21	17	26	20	25	223
	b. Sungsang	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
	c. Vacum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik 3.3.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Tahun 2025



Analisis	1. Pada tahun 2025 pelayanan Sectio Caesaria yang tertinggi pada bulan April yaitu 75 pasien disebabkan banyak kasus yang tidak bisa dilayani dengan persalinan normal dan terendah Sectio Caesaria di bulan februari yaitu 54 pasien disebabkan banyak kasus inpartu dengan resiko rendah sehingga bisa dilayani dengan Tindakan persalinan normal. Pada tahun 2024 pelayanan SC tertinggi pada bulan juli yaitu 77 pasien terendah pada bulan Desember yaitu 50 pasien. Pada tahun 2023 pelayanan SC tertinggi pada
----------	--

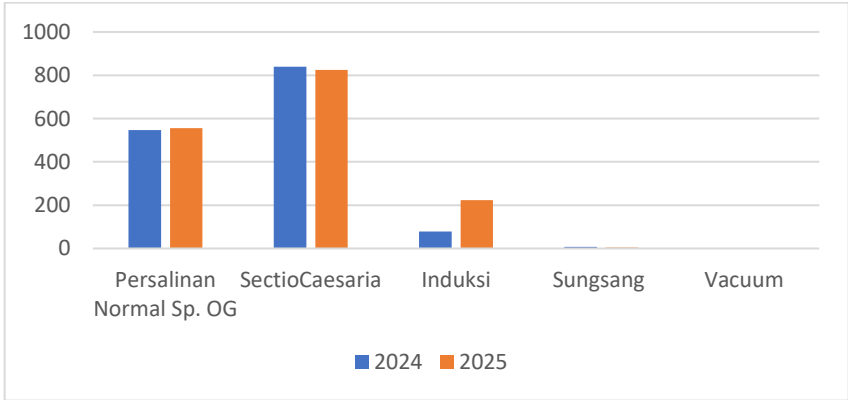


	bulan oktober yaitu 90 pasien dan terendah pada bulan April yaitu 55 pasien. 2. Pada tahun 2025 Pelayanan Persalinan normal tertinggi di bulan Maret yaitu 72 pasien, disebabkan banyak kasus yang bisa dilayani dengan resiko rendah dan persalinan paling rendah di bulan february yaitu 27 pasien disebabkan banyak kasus resiko tinggi yang harus dilakukan Tindakan SC, Pada tahun 2024 persalinan normal tertinggi pada bulan September yaitu 49 pasien, terendah pada bulan february yaitu 37 pasien. Pada tahun 2023 persalinan normal tertinggi pada bulan November yaitu 50 pasien, terendah pada bulan juli yaitu 24 pasien. 3. Tidak semua pasien dilayani dengan observasi induksi/drip, hanya kasus-kasus tertentu yang dilakukan tindakan tersebut, tindakan ini dilakukan disebabkan ada kasus-kasus tertentu seperti his kurang adekuat.
Rencana Tindak lanjut	1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk. 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan. 3) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.3.2 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Maternal Tahun 2025
Tabel 3.3.2 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Maternal Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	Persalinan Normal Sp. OG	601	547	93,02%	555	92,3%
2	<i>SectioCaesaria</i>	924	840	92,5%	824	89,17%
3	Induksi	86	79	52,31%	223	259%
4	Sungsang	0	8	80%	4	44,4%
6	Vacuum	0	0	0	0	0

Grafik 3.3.2 Jumlah Pencapaian Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025



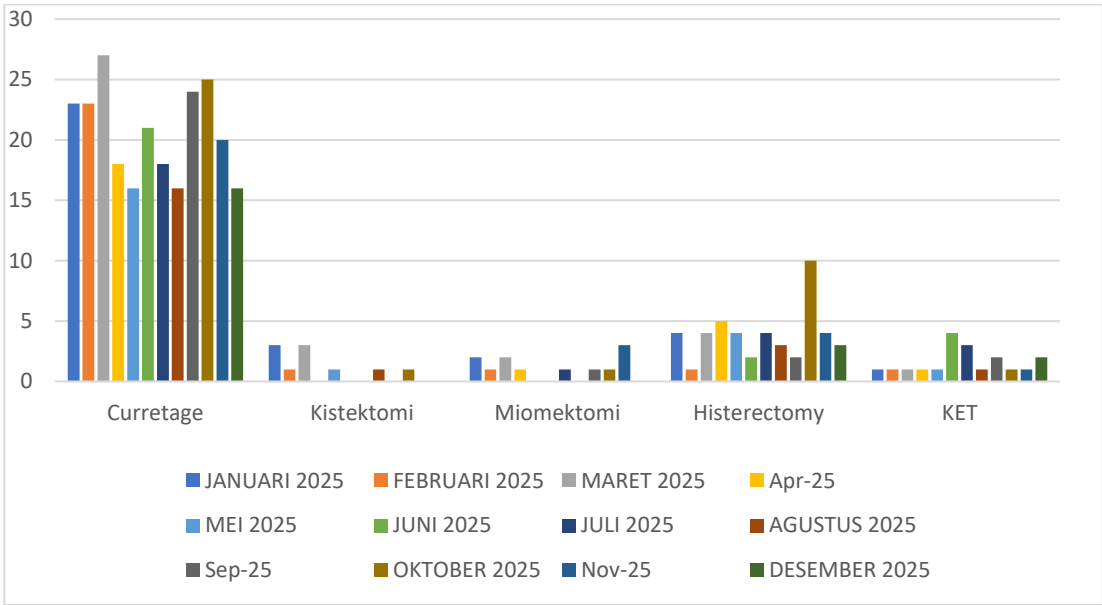
Analisa	Pada tahun 2025 terdapat jumlah tindakan tertinggi yaitu SC sebanyak 824 pasien, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 826 pasien dan tahun 2023 yaitu 826 pasien .Tindakan persalinan normal yaitu sebanyak 555 pasien meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu 535 pasien dan tahun 2023 yaitu 439 pasien. Pada tindakan induksi/Drip yaitu sebanyak 223 pasien meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu 79 pasien dan tahun 2023 yaitu 138 pasien.
RTL	1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk. 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan. 3) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.3.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Gynekologi Tahun 2025

Tabel 3.3.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Gynekologi Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien												Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1														
	a. Curretage	23	23	27	18	16	21	18	16	24	25	20	16	247
	b. Kistektomi	3	1	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	10
	c. Miomektomi	2	1	2	1	0	0	1	0	1	1	3	0	12
	d. Histerectomy	4	1	4	5	4	2	4	3	2	10	4	3	51
	e. KET	1	1	1	1	1	4	3	1	2	1	1	2	20

Grafik 3.3.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Gynekologi Tahun 2025





Analisis	Pada tahun 2025 terdapat jumlah tindakan tertinggi yaitu curettage 25 pasien jika dibandingkan dengan tindakan hysterektomi, kistektomi, miomektomi dan KET. <i>Curettage</i> dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya
RTL	1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien gynekologi 2. Peningkatan Deteksi Dini dan Skrining

3.3.4 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Gynekologi Tahun 2025
Tabel 3.3.4 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Gynekologi Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	Curretage	277	252	96,9%	247	89,1%
2	Kistektomi	17	16	80%	10	58,8%
3	Miomektomi	5	4	80%	12	240%
4	Histerectomy	26	24	60%	37	142,3%
5	KET	35	25	83,3%	19	54,2%

Analisis	Pada tahun 2025 terdapat jumlah tindakan tertinggi curettage yaitu 25 pasien jika dibandingkan dengan tindakan hysterektomi, kistektomi, miomektomi dan KET. <i>Curettage</i> dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya
Rencana Tindak Lanjut	1.Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien gynekologi 2.Peningkatan Deteksi Dini dan Skrining

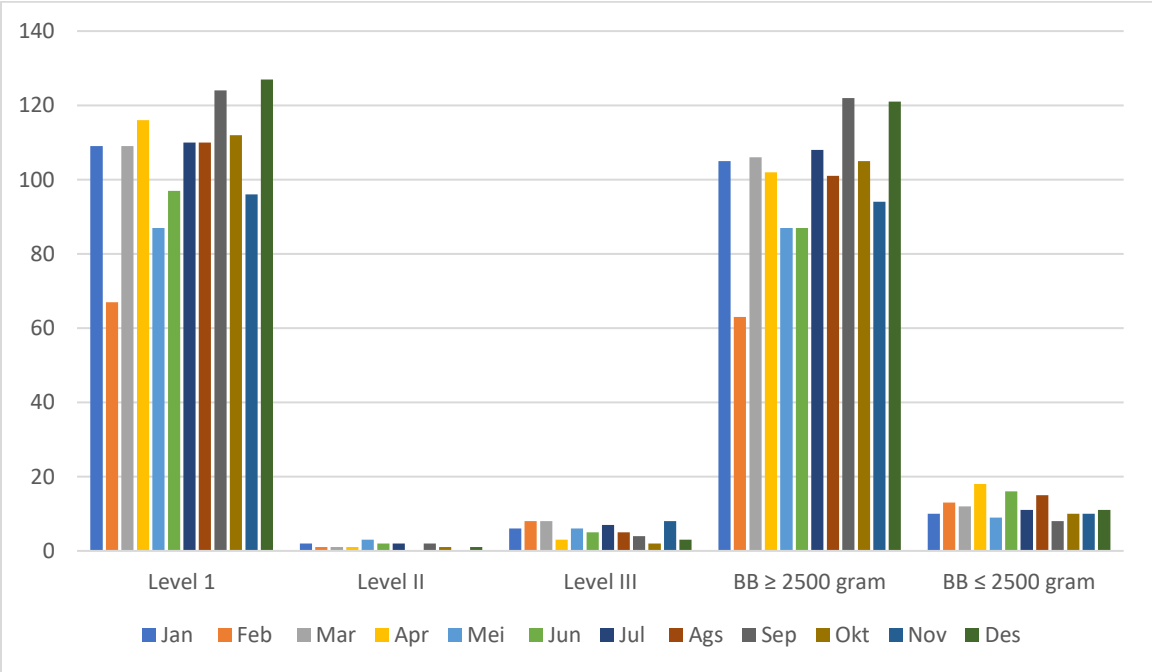


3.3.5 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

Tabel 3.3.5. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal RSPHM Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien												Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1														
	a.Level 1 /rawat gabung	109	67	109	116	87	97	110	110	124	112	96	127	1.154
	b.Level II /rujukan dari luar	2	1	1	1	3	2	2	0	2	1	0	1	15
	c.Level III /NICU	6	8	8	3	6	5	7	5	4	2	8	3	65
2														
	BB ≥ 2500 gram	105	63	106	102	87	87	108	101	122	105	94	121	1201
	BB ≤ 2500 gram	10	13	12	18	9	16	11	15	8	10	10	11	143

Grafik 3.3.5. Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal RSPHM Tahun 2025



Analisis	Dari tabel dan grafik 3.3.5 diatas tampak bahwa tren kunjungan pasien di Neonatologi fleksibel naik turun 1. Kunjungan tertinggi perawatan bayi ada di level 1 dan kunjungan terendah ada di level 2 disebabkan perawatan mulai dari kehamilan dan persalinan pasien selalu dipantau kondisi bayi 2. Berat badan bayi lebih tinggi ada di BB lebih dari 2500 dibandingkan berat badan rendah disebabkan sejak kehamilan ibu hamil sudah dipantau nutrisi ibu dan kondisi ibu dan janin. 3. Kematian bayi < 7 hari tertinggi ada di bulan September yaitu 4 pasien disebabkan bayi lahir imatur
RTL	1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.



	2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
--	--

3.3.6 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Neonatal Tahun 2025

Tabel 3.3.6 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Neonatal Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	Level 1	1436	1306	92,16%	1.154	80,3%
2	Level II	75	69	70%	15	20%
3	Level III	84	77	74,03%	65	77,3%
4	BB ≥ 2500 gram	1406	1279	98%	1201	85,4%
5	BB ≤ 2500 gram	0%	169		143	

Analisis	1. Pada tahun 2025 pencapaian kegiatan pelayanan Neonatal level 1 belum mencapai target, yaitu 80,3%, level II tercapai 20%. Level III tercapai 77,3% 2. BB ≤ 2500 gram pada tahun 2025 tidak tercapai dengan target tiap tahun 0% sedangkan pada tahun 2025 yaitu terdapat 143 bayi.
Rencana Tindak Lanjut	1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur. 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR

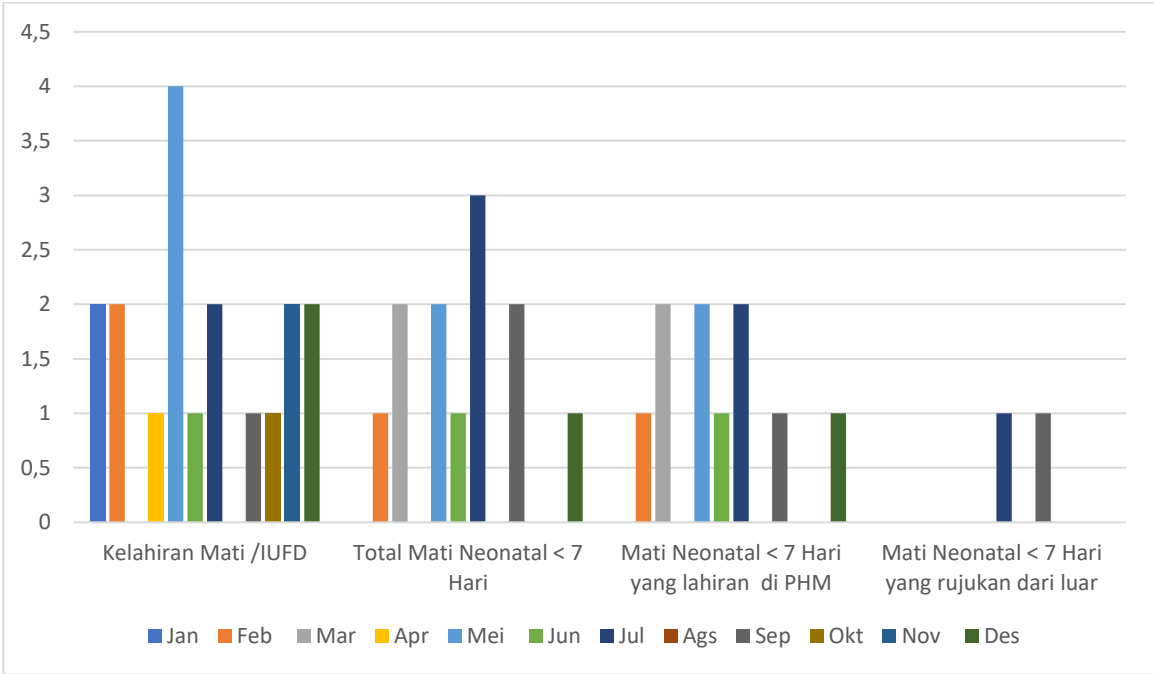


3.3.7 Jumlah Kelahiran Mati Neonatal

Tabel 3.3.7 Jumlah Jumlah Kelahiran Mati Neonatal RSPHM Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien												Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Kelahiran Mati /IUFD	2	2	0	1	4	1	2	0	1	1	2	2	18
2	Total Mati Neonatal < 7 Hari	0	1	2	0	2	1	3	0	2	0	0	1	12
	Mati Neonatal < 7 Hari yang lahiran di PHM	0	1	2	0	2	1	2	0	1	0	0	1	10
	Mati Neonatal < 7 Hari yang rujukan dari luar	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2

Grafik 3.3.7 Jumlah Kelahiran Neonatal RSPHM Tahun 2025



Analisa	- Kelahiran Mati /IUFD tertinggi pada bulan mei yaitu 4 pasien. - Kematian bayi < 7 hari tertinggi ada di bulan juli yaitu 3 pasien disebabkan bayi lahir imatur
RTL	- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur. - Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah kelahiran premature - Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

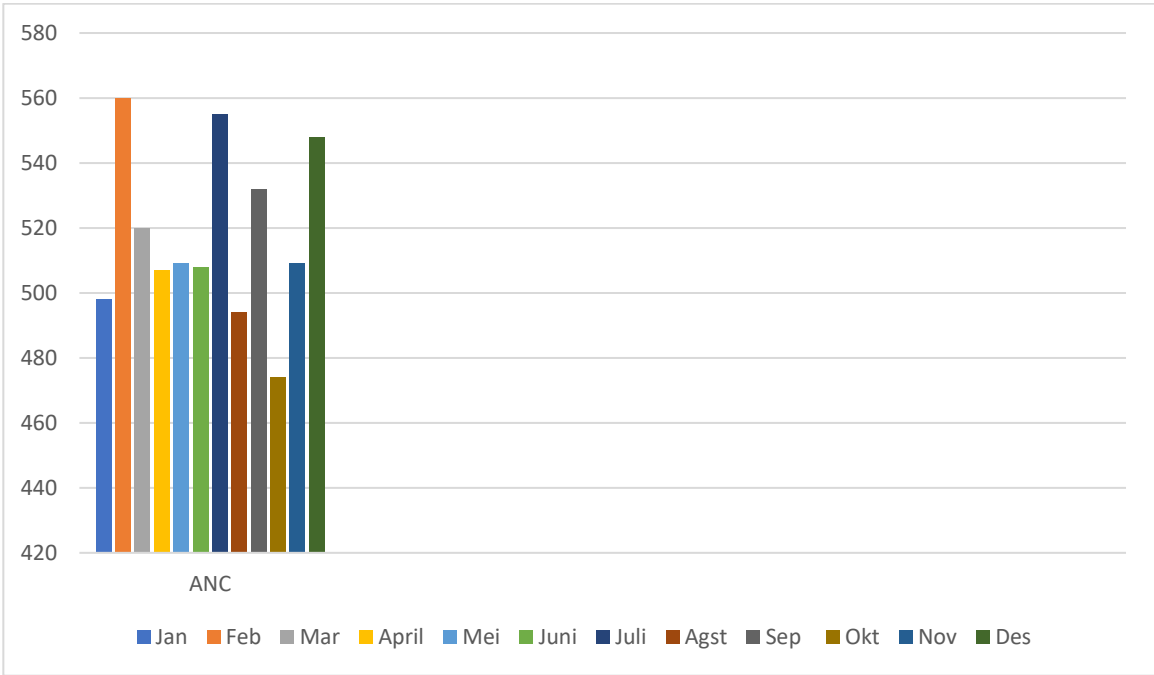


3.3.8 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel 3.3.8 Pelayanan Ante Natal Care (ANC) RSPHM Tahun 2025

Jenis Pelayanan	Jumlah												Σ 2025
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
ANC	498	560	520	507	509	508	555	494	532	474	509	548	5.740

Grafik 3.3.8
Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025



Evaluasi	Dari tabel dan grafik 3.3.8 diatas tampak bahwa tren kunjungan pasien di poli obgyn fleksibel naik turun. Kunjungan tertinggi terjadi pada bulan februari . yaitu 560 pasien disebabkan banyak kasus kehamilan yang harus dipantau dengan dokter obgyn dan kunjungan terendah di bulan agustus Yaitu 494 pasien hal ini disebabkan karena kondisi ibu hamil yang sudah bisa dilayani di faskes tingkat 1 sehingga tidak memerlukan rujukan di faskes tingkat 2.
RTL	1) Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn 2) Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi 3) Melakukan Program kelas ibu hamil



3.3.9 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan ANC Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025

Tabel 3.3.9 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan ANC Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	ANC	7.656	6.960	90,5%	5740	74,9%

Analisa	Pada tahun 2025 capaian kegiatan pelayanan ANC pada tahun 2025 belum memenuhi target, target terpenuhi 74,9% dibandingkan tahun 2024 yaitu 6.960 pasien disebabkan kondisi ibu hamil yang sudah bisa dilayani di faskes tingkat 1 sehingga tidak memerlukan rujukan di faskes tingkat 2.
Rencana Tindak Lanjut	1. Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn 2. Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi 3. Melakukan Program kelas ibu hamil

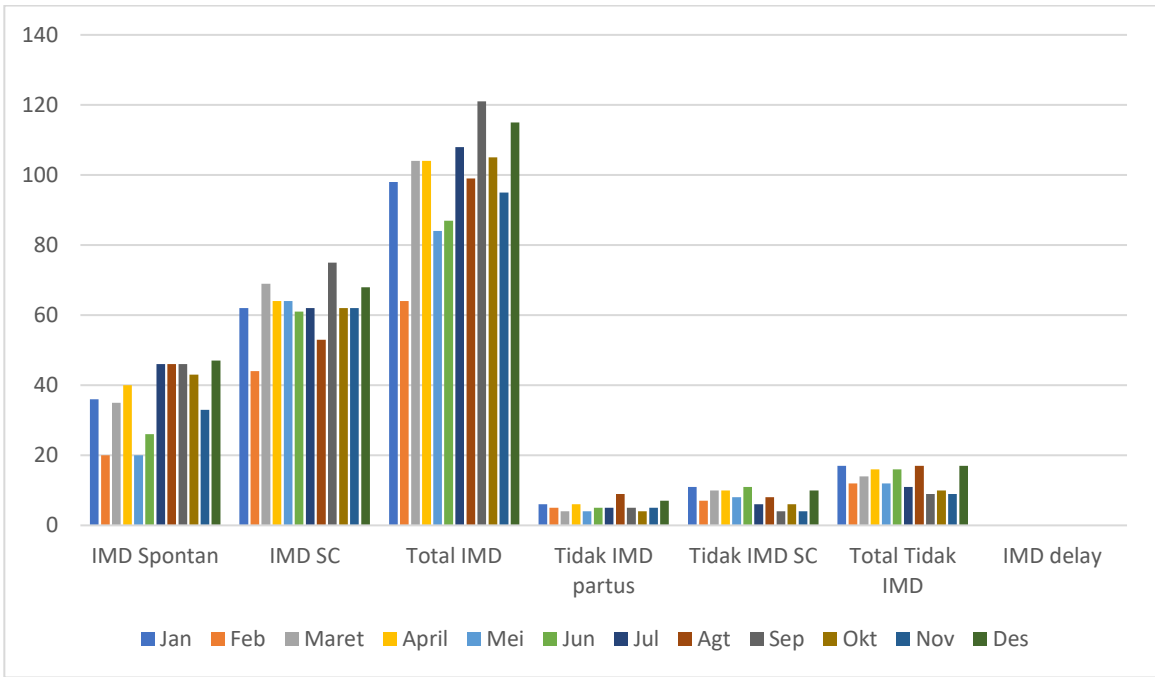
3.3.10 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel 3.3.10 Inisiasi Menyusu Dini (IMD) RSPHM Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien												Σ
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	IMD Spontan	36	20	35	40	20	26	46	46	46	43	33	47	438
2	IMD SC	62	44	69	64	64	61	62	53	75	62	62	68	746
3	Total IMD	98	64	104	104	84	87	108	99	121	105	95	115	1.184
4	Tidak IMD partus	6	5	4	6	4	5	5	9	5	4	5	7	65
5	Tidak IMD SC	11	7	10	10	8	11	6	8	4	6	4	10	95
6	Total Tidak IMD	17	12	14	16	12	16	11	17	9	10	9	17	160
7	IMD delay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Grafik 3.3.10
Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Malang Tahun 2025



Analisis	Dari tabel dan grafik 3.3.10 diatas tampak bahwa tren pelayanan IMD fleksibel naik turun. 1. Tidak dilakukan IMD setelah partus tertinggi pada bulan agustus yaitu 9 bayi yang disebabkan bayi lahir premature sehingga harus di lakukan perawatan lebih lanjut 2. Sedangkan pada kelahiran SC tidak dilakukan IMD tertinggi pada bulan juni yaitu 11 pasien yang di sebabkan bayi lahir premature sehingga harus di lakukan perawatan lebih lanjut 3. Semua bayi dengan kondisi lahir baik dan ibu kondisi baik dilakukan IMD, dengan kasus ibu dan bayi kurang baik yang tidak bisa dilakukan IMD.
RTL	1. Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat atautkah tidak 2. Mempertahankan Konsistensi Pelaksanaan IMD 3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan IMD 4. Edukasi sejak ANC tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.

3.3.10 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025

Tabel 3.3.10 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	IMD	1.071	974	89.93%	1.080	100%
2	Tidak IMD	0	162	0	160	0

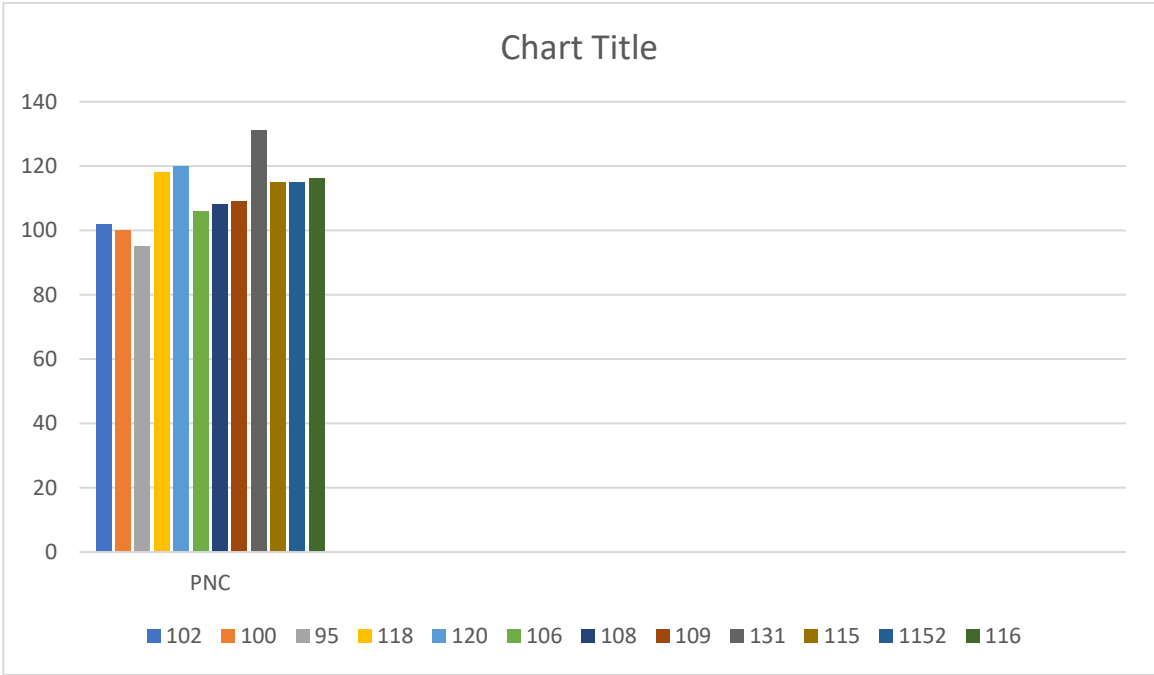
Analisa	Pencapaian Kegiatan pelayanan IMD pada tahun 2025 mencapai 100% di bandingkan denga tahun 2024 yaitu 89.93% dikarenakan semua bayi baru lahir sehat tidak ada komplikasi segera dilakukan IMD pada saat persalinan
Rencana Tindak Lanjut	1. Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak 2. Mempertahankan Konsistensi Pelaksanaan IMD 3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan IMD 4. Edukasi sejak ANC tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.

3.3.11 Pelayanan Post Natal Care (PNC)

Tabel 3.3.11 Pelayanan Post Natal Care (PNC) RSPHM Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah												Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	PNC	102	100	95	118	120	106	108	109	131	115	115	116	1335

Grafik 3.3.11
Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Malang Tahun 2025



Evaluasi	Dari tabel dan grafik 3.3.11 diatas tampak bahwa tren kunjungan pasien PNC fleksibel naik turun Kunjungan tertinggi terjadi pada bulan mei yaitu 120 pasien hal ini disebabkan karena jumlah pasien post partum normal dan post SC meningkat dan kunjungan paling rendah ada pada bulan maret yaitu 95 pasien disebabkan kunjungan post partum dan post sc menurun.
RTL	Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.3.12 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan PNC Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025

Tabel 3.3.12 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan PNC Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	PNC	1485	1350	90%	1335	89.8%

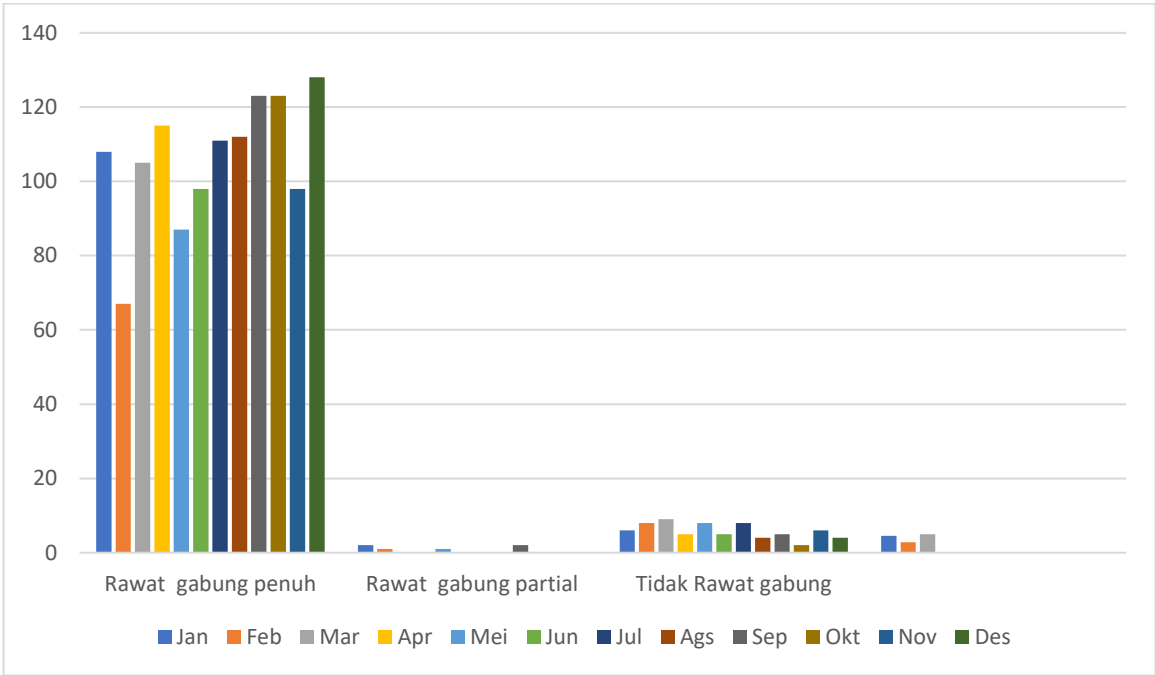
Evaluasi	Pencapaian Kegiatan Pelayanan PNC pada tahun 2025 yaitu 89,8%, menurun di bandingkan tahun 2024 yaitu 90%
RTL	1) Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas (KF1: 6–48 jam, KF2: 3–7 hari, KF3: 8–28 hari, KF4: 29–42 hari) 2) Melakukan edukasi tanda bahaya nifas 3) Melakukan eduaksi pentingnya KB pasca salin

3.3.13 Pelayanan Rawat Gabung

Tabel 3.3.13 Pelayanan Rawat Gabung RSPHM Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien												Σ 2025
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Rawat gabung penuh	108	67	105	115	87	98	111	112	123	123	98	128	1275
2	Rawat gabung partial	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	6
3	Tidak Rawat gabung	6	8	9	5	8	5	8	4	5	2	6	4	70

Grafik 3.3.13
Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2025



Evaluasi	Dari tabel dan grafik 3.3.13 diatas tampak bahwa tren pasien rawat gabung fleksibel naik turun. - Kunjungan tertinggi pada pasien rawat gabung pada bulan desember yaitu 128 disebabkan banyak kondisi ibu dan bayi baik. - Bayi tidak rawat gabung tertinggi di bulan mei dan juli yaitu 8 pasien disebabkan banyak kondisi lahir bayi yang kurang baik dan terendah di bulan oktober yaitu 2 pasien disebabkan kondis bayi saat lahir baik - Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu perawatan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.
RTL	- Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi. - Fasilitasi ibu untuk memerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan) - Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan) - Pelaksanaan Kangaroo Mother Care pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.3.14 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Rawat Gabung RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.14 Jumlah Pencapaian Kegiatan Pelayanan Rawat Gabung RSPHM Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	Rawat gabung penuh	1438	1308	90%	1275	97,4%
2	Rawat gabung partial	9	8	90%	6	66,6%
3	Tidak Rawat gabung	73	67	90%	70	95%

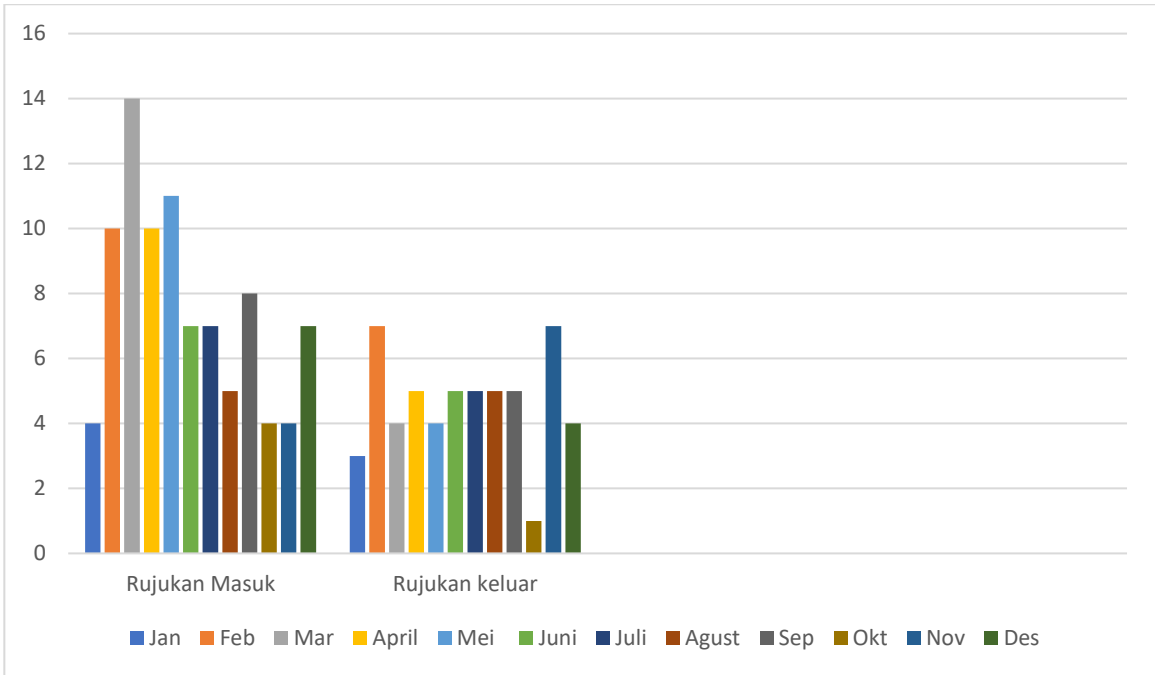
Analisis	Pencapaian Kegiatan Pelayanan Rawat Gabung pada tahun 2025 belum mencapai target yaitu 97,4% turun dibandingkan tahun 2024 yaitu 90%
Rencana Tindak Lanjut	1. Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi. 2. Fasilitasi ibu untuk memerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan) 3. Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan) 4. Pelaksanaan Kangaroo Mother Care pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.3.15 Pelayanan Jejaring Rujukan

Tabel 3.3.15 Pelayanan Jejaring Rujukan RSPHM Tahun 2025

No	Rujukan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Σ 2025
1	Rujukan Masuk	4	10	14	10	11	7	7	5	8	4	4	7	91
2	Rujukan keluar	3	7	4	5	4	5	5	5	5	1	7	4	54

Grafik 3.3.15
Pelayanan Jejaring Rujukan RSPHM Tahun 2025



Analisis	1. Dari tabel dan grafik 3.3.15 diatas tampak bahwa tren rujukan masuk pasien maternal dan NICU fleksibel naik turun, rujukan tertinggi terjadi pada bulan maret yaitu 14 pasien hal ini disebabkan karena banyak kasus yang tidak bisa dilayani di fasket tingkat 1 dan rujukan paling rendah ada pada bulan januari, oktober november yaitu 4 pasien hal ini disebabkan karena faskes 1 lebih memilihujuk ke faskes 2 yang lain. 2. Dari tabel dan grafik 3.3.15 diatas tampak bahwa tren rujukan eksternal pasien di Maternitas dan NICU fleksibel naik turun. Rujukan tertinggi terjadi pada bulan februari yaitu 7 pasien hal ini disebabkan karena pasien belum bisa membaik setelah dilakukan perawatan dan rujukan eksternal paling rendah ada pada bulan oktober yaitu 1 pasien hal ini disebabkan karena paisen bisa ditangani di RS
RTL	1) Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama 2) Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.3.16 Jumlah Pencapaian Pelayanan Jejaring Rujukan RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.16 Pencapaian Pelayanan Jejaring Rujukan RSPHM Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	Rujukan Masuk	101	92	89,1	91	90%

Analisis	Pencapaian Pelayanan Jejaring Rujukan pada tahun 2025 yaitu 90%, belum memenuhi target
Rencana Tindak Lanjut	1) Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama 2) Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.3.16 Laporan Pembinaan jejaring

Tabel 3.3.16 Laporan Pembinaan jejaring RSPHM Tahun 2025

NO	Tema Pembinaan Jejaring	JUMLAH PESERTA		TGL Pelaksana n	Hasil evaluasi
		Σ undangan	Σ Hadir		
1	Worksop Kegawatdarurat an Maternal	50	41	18 Februari 2025	1. Hasil Evaluasi Pembinaan jejaring bulan Februari 2025 pelayanan keseluruhan rujukan di RS 76,4% menunjukkan prosentasi baik, 25% menunjukkan prosentasi sangat baik, dan 1% menunjukkan prosentasi kurang baik. 2. Kendala dari perujuk: 15% perujuk mengatakan proses rujukan lama 3 % Pengisian google form terlalu ribet dan lama 2 % Kesusahan menghubungi IGD 3. Masukan dari perujuk : - Di percepat proses rujukannya - Informasi balik ke perujuk 4. Kepuasan dari perujuk 20% perujuk menyampaikan Pelayanan cepat 80% perujuk menyampaikan Respon dan Pelayanan baik
2	Workshop Stabilisai Pra Rujukan Neonatal	52	36	9 Mei 2025	1.Hasil Evaluasi Pembinaan jejaring bulan Mei 2025 pelayanan keseluruhan rujukan di RS 74,8% menunjukkan prosentasi baik, 24,4% menunjukkan prosentasi sangat baik, dan 0,80% menunjukkan prosentasi kurang baik. 1. Kendala dari perujuk:



	Sasaran : Bidan ,PKM, Klinik				• 20% perujuk mengatakan proses rujukan lama • 3% Kesusahan menghubungi IGD • 1% Wa perujuk tidak direspon 2. Masukan dari perujuk : • Di perbaiki proses rujukannya perlu diperbaiki sisten penerimaan rujukan • Memberikan informasi ke perujuk pasien yang sudah di tangani. • Keadaan darurat harusnya diterima saja 3. Kepuasan dari perujuk • 70% perujuk menyampaikan Pelayanan cepat • 30 % perujuk menyampaikan Respon dan Pelayanan baik
3	Seminar “Pendampingan ibu hamil dengan hypnoregnancy”	100	87	18 ktober 2025	5. Hasil Evaluasi Pembinaan jejaring bulan Oktober 2025 pelayanan keseluruhan rujukan di RS 75,9% menunjukkan prosentasi baik, 23,3% menunjukkan prosentasi sangat baik, dan 0,71% menunjukkan prosentasi kurang baik. 6. Kendala dari perujuk: • 14,2% perujuk mengatakan proses rujukan lama • 2,3% Pengisian google form terlalu ribet dan lama • 2,3% Kesusahan menghubungi IGD 7. Masukan dari perujuk : • Di perbaiki proses rujukannya • Pasien yg dirujuk kalau keadaan darurat itu diterima dulu saja biar cepat ditangani dulu mengingat pasien butuh alat yg lebih lengkap daripada di tpmb yg alatny terbatas • Sebaiknya bila kita habis merujuk pasien ada informasi balik yg di berikan ke bidan • Kasus gawat darurat kebidanan di sambungkan link Kamar Barsalin 8. Kepuasan dari perujuk • 16% perujuk menyampaikan Pelayanan cepat • 33 % perujuk menyampaikan Respon dan Pelayanan baik



3.3.17 Jumlah Pencapaian pembinaan jejaring RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.17 Pencapaian pembinaan jejaring RSPHM Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	Pembinaan Jejaring	3x/tahun	1	33,3%	3	100%

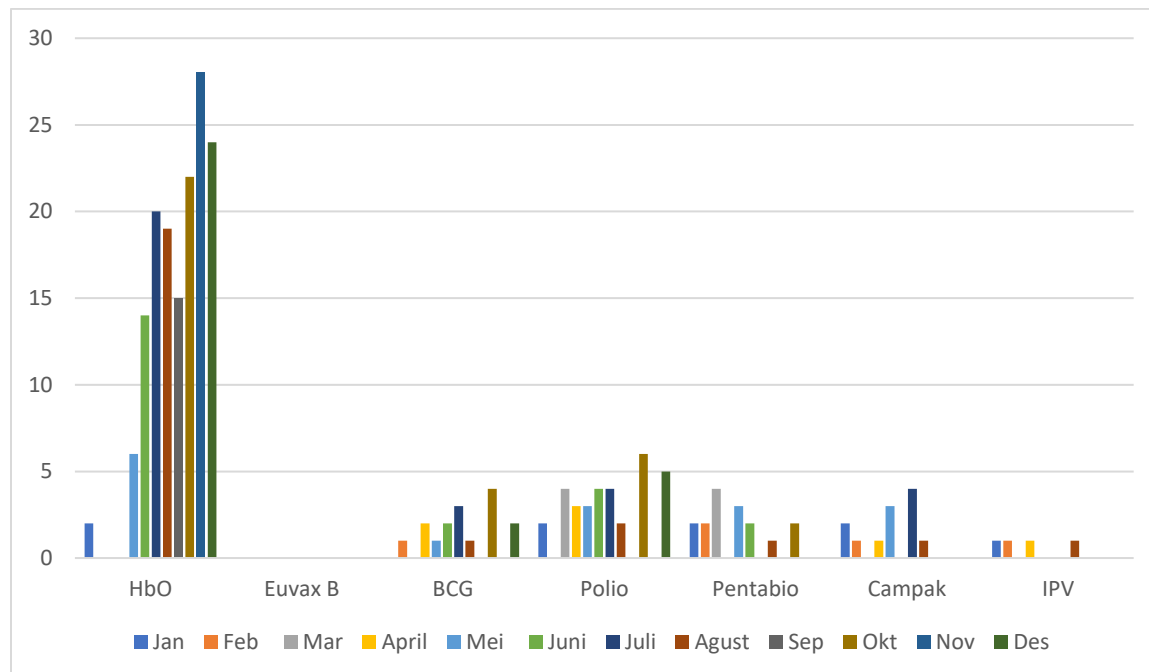
Analisis	Pencapaian pembinaan jejaring pada tahun 2025 sudah mencapai target 3 kali/ tahun, sedangkan tahun 2024 tidak mencapai target yaitu 1 kali pelaksanaan
Rencana Tindak lanjut	1. Mempertahankan Hubungan dan Koordinasi Jejaring 2. Peningkatan Kualitas Sistem Rujukan 3. Monitoring dan Evaluasi Jejaring 4. Pemberian Umpan Balik kepada perujuk

3.3.18 Pelayanan Imunisasi

Tabel 3.3.18 Pelayanan Imunisasi RSPHM Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah												Σ 2025
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	HbO	2	0	0	0	6	14	20	19	15	22	28	24	150
2	Euvax B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BCG	0	1	0	2	1	2	3	1	0	4	0	2	16
3	Polio	2	0	4	3	3	4	4	2	0	6	0	5	33
4	Pentabio	2	2	4	0	3	2	0	1	0	2	0	0	14
5	Campak	2	1	0	1	3	0	4	1	0	0	0	0	12
6	IPV	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4

Grafik 3.3.18 Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi	Dari tabel dan grafik 3.3.18 diatas tampak bahwa tren kunjungan pasien Imunisasi fleksibel naik turun. Kunjungan imunisasi Hepatitis B tidak memenuhi jumlah kelahiran di RS, sudah pengajuan vaksin di puskesmas singosari dan ardimulyo, puskesmas tersebut tidak bisa memberikan sejumlah kelahiran dikarenakan vaksin dari dinas kesehatan terbatas.
RTL	1. Melakukan edukasi kepada orang tua bayi untuk imunisasi di puskesmas jika tidak mendapatkan vaksin khususnya HbO di RS 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi non pemerintah

3.3.19 Jumlah Pencapaian Pelayanan Imunisasi RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.19 Jumlah Pencapaian Pelayanan Imunisasi RSPHM Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	HbO	691	629	90%	12	1,73%
2	Euvax B	0	0	0%	0	0%
3	BCG	34	31	87%	1	2,9%
4	Polio	76	69	92%	3	3,9%
5	Pentabio	40	36	89%	1	2,5%
6	Campak	26	24	79%	1	3,8%
7	IPV	24	22	88%	0,3	1,2%

Analisa	Pencapaian Pelayanan Imunisasi tahun 2025 untuk imunisasi Hb 0 belum sesuai target yatitu 1,73% dikarenakan imunisasi Hb0 terbatas dari puskesmas,
Rencana Tindak Lanjut	1. Melakukan edukasi kepada orang tua bayi untuk imunisasi di puskesmas jika tidak mendapatkan vaksin khususnya HbO di RS 2. Edukasi pemakaian vaksin euvax B dengan biaya mandiri 3. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi non pemerintah

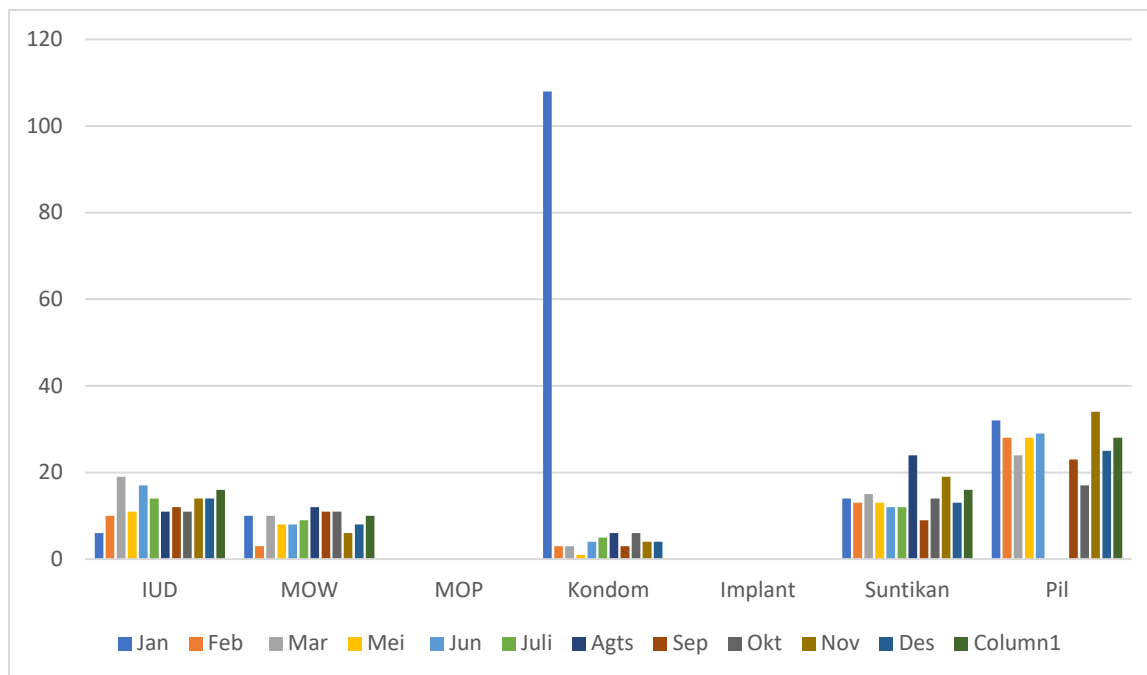
3.3.20 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.20 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah Pasang												Σ 2025
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	IUD	6	10	19	11	17	14	11	12	11	14	14	16	155
2	MOW	10	3	10	8	8	9	12	11	11	6	8	10	106
3	MOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	108	3	3	1	4	5	6	3	6	4	4	0	147
5	Implant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	14	13	15	13	12	12	24	9	14	19	13	16	174
7	Pil	32	28	24	28	29	0	0	23	17	34	25	28	268



Grafik 3.3.20 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2025



Evaluasi	Dari tabel dan 3.3.20 dan Grafik 3.3.20 1. Total pelayanan KB didominasi oleh metode Pil yaitu 268, diikuti Suntik yaitu 174 kondom yaitu 147, MOW yaitu 106, IUD yaitu 155, 2. Metode MOP dan Implant tidak ada pemakaian yaitu 0 sepanjang tahun 2025. 3. Program KB tahun 2025 berjalan cukup baik dari sisi jumlah, namun masih didominasi metode jangka pendek, metode jangka panjang dan permanen belum optimal
RTL	1. Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit. 2. Melakukan edukasi ke semua pasien bersalin dan curettage abortus 3. Berkolaborasi dengan PJ KB RS untuk meningkatkan capain KB 4. Membuat Poster KB yang di tampilkkkan di Ruang Tunggu Poli Obgyn 5. Melakukan edukasi Mengedukasi pasien di Poli Obgyn dan peserta senam hamil 6. Melakukan edukasi ke pasien untuk melakukan KB pasca salin 7. Melakukan edukasi ke pasien untuk melakukan KB pasca curretage

3.3.21 Jumlah Pencapaian Pelayanan Keluarga Berencana (KB) RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.21Jumlah Pencapaian Pelayanan Keluarga Berencana (KB) RSPHM Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET 2025 10% dari tahun 2024	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	IUD	161	151	89,4	155	96%
2	MOW	116	106	89,6	106	91%
3	MOP	0	0	0	0	0%
4	Kondom	544	495	89,8%	147	27%
5	Implant	0	0	0	0	0%
6	Suntikan	161	147	89,7	174	100%
7	Pil	207	189	89,9	268	100%

Analisis	1. Terdapat variasi capaian antara metode KB pada tahun 2025 2. Beberapa metode melampaui target, sementara yang lain jauh di bawah target bahkan tidak ada capaian. 3. Metode dengan Capaian Melebihi Target yaitu suntikan 174 (lebih dari 100%),Pil: 268 (lebih dari 100%), metode ini sangat diminati masyarakat karena mudah digunakan, tidak invasif, dan mudah diakses, namun, menunjukkan ketergantungan tinggi pada metode jangka pendek. 4. Metode dengan Capaian Mendekati Target yaitu IUD: 155 (96%), MOW: 106 (91%), Sudah cukup baik, terutama IUD sebagai metode jangka panjang.
RTL	1. Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit. 2. Melakukan edukasi ke semua pasien bersalin dan curettage abortus 3. Berkolaborasi dengan PJ KB RS untuk meningkatkan capain KB 4. Membuat Poster KB yang di tampilkan di Ruang Tunggu Poli Obgyn 5. Melakukan edukasi Mengedukasi pasien di Poli Obgyn dan peserta senam hamil 6. Melakukan edukasi ke pasien untuk melakukan KB pasca salin 7. Melakukan edukasi ke pasien untuk melakukan KB pasca curretage

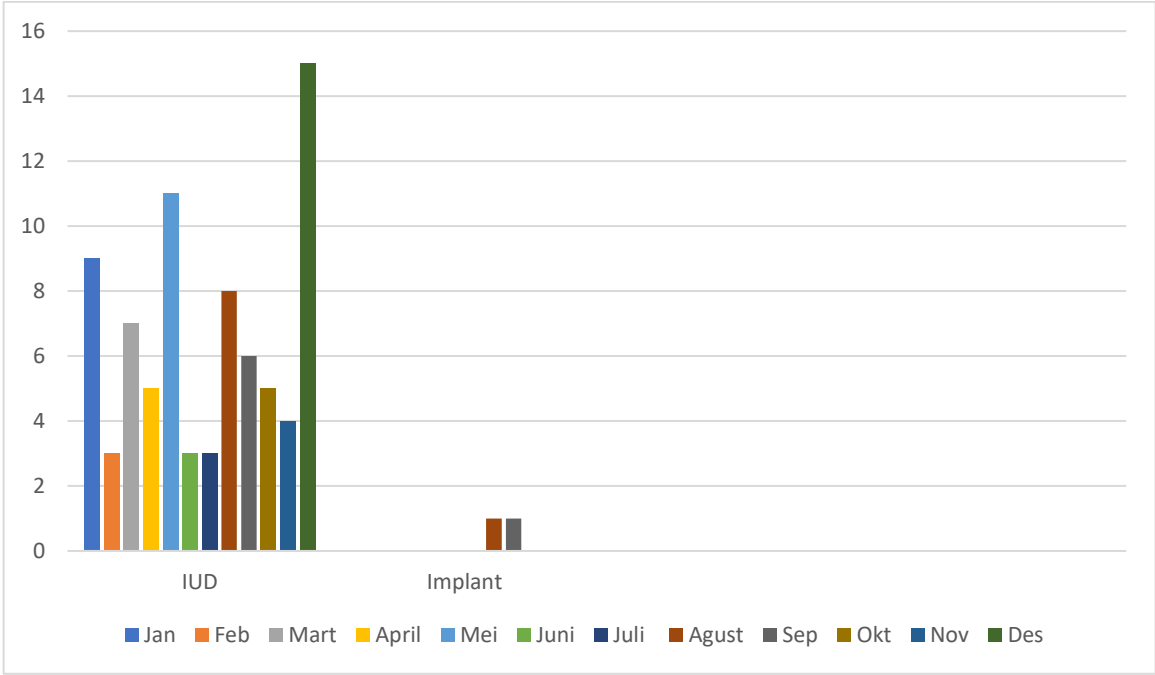
3.3.22 Pelayanan Lepas Keluarga Berencana (KB) RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.22 Jumlah Lepas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) RSPHM Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah Lepas												Σ 2025
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	IUD	9	3	7	5	11	3	3	8	6	5	4	15	79
2	Implant	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2



Grafik 3.3.22 Jumlah Lepas Pelayanan Keluarga Berencana (KB) RSPHM Tahun 2025

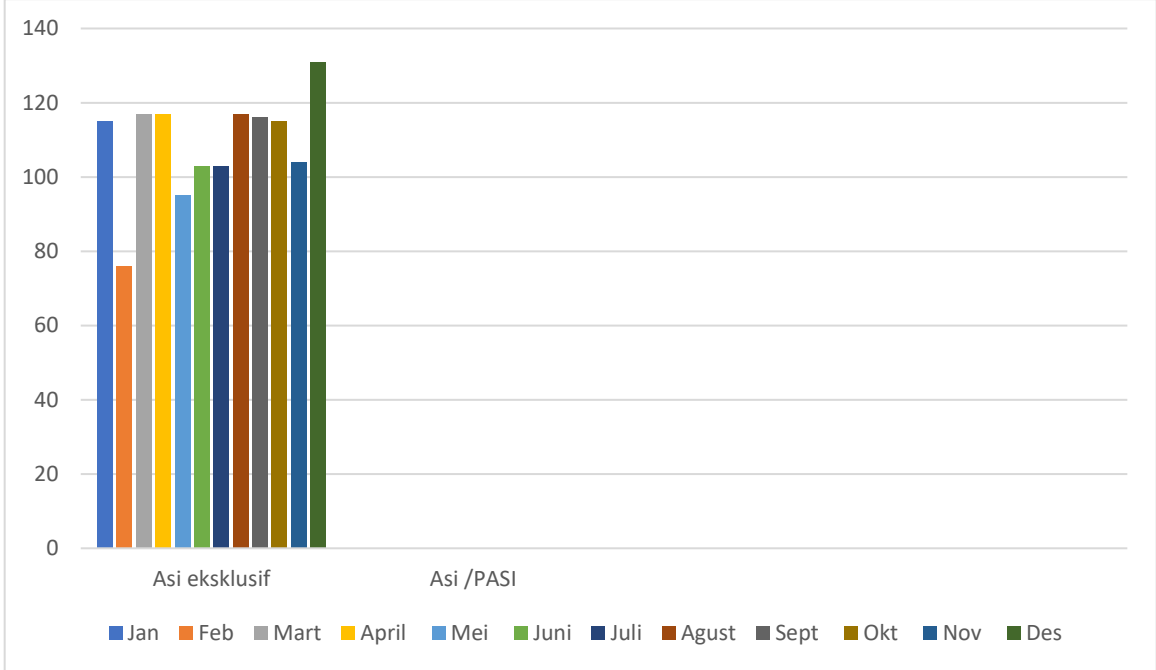


Evaluasi	1. Dari tabel dan 3.3.21 dan Grafik 3.3.21 diatas tampak bahwa tren kunjungan pasien lepas KB tiap bulan bervariasi. Pola menunjukkan fluktuasi namun relatif stabil sepanjang tahun. Tertinggi lepas IUD pada bulan mei yaitu 11 pasien dan terendah di bulan di bulan februari, juni dan juli yaitu 3 pasien 2. Pada pasien aff implat tahun 2025 Pelepasan sangat rendah (hanya 2 kasus) dalam setahun. Hanya terjadi pada Agustus 1 kasus, September 1 kasus, Bulan lain: 0 kasus. Hal ini menunjukkan Penggunaan implant kemungkinan lebih sedikit.
RTL	1. Memperkuat konseling pasca pemasangan (follow-up) untuk mencegah drop out 2. Memperkuat pencatatan dan pelaporan (register KB & rekam medis)

3.3.23 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 3.3.23 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif RSPHM Tahun 2025

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien												Σ 2025
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Asi eksklusif	115	76	117	117	95	103	103	117	116	115	104	131	1309
2	Asi /PASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik 3.23 Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025



Evaluasi	Dari tabel dan 3.3.23 dan Grafik 3.3.23 diatas tampak bahwa pelayanan Pemberian ASI Eksklusif fleksibel naik turun. Pemberian ASI Eksklusif tertinggi terjadi pada bulan maret, April, agustus yaitu 117 bayi dan terendah pada bulan mei yaitu 95 bayi, rata-rata semua bayi yang lahir di RS Prima Husada mendukung ASI Eksklusif tidak ada yang di beri susu formula
RTL	Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.3.24 Jumlah Pencapaian Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.24 Jumlah Pencapaian Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RSPHM Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	Asi eksklusif	1576	1.433	90%	1309	91,3%
2	Asi /PASI	0	0	100%	0	100%

Analisis	1. Terjadi penurunan jumlah absolut dari 1.433 pada tahun 2024 menjadi 1.309 pada tahun 2025 2. Namun, secara persentase terjadi peningkatan dari 90% menjadi 91,3%. 3. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jumlah sasaran menurun di tahun 2025, sehingga persentase meningkat meskipun jumlah absolut turun. 4. Kinerja pelayanan relatif lebih efektif dalam menjangkau sasaran yang ada.
RTL	1. Melakukan identifikasi penyebab penurunan jumlah bayi di karenakan jumlah persalinan menurun 2. Memperkuat jejaring rujukan dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) agar ibu bersalin tetap terpantau hingga masa menyusui.



3. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan agar seluruh sasaran terdata dengan baik.

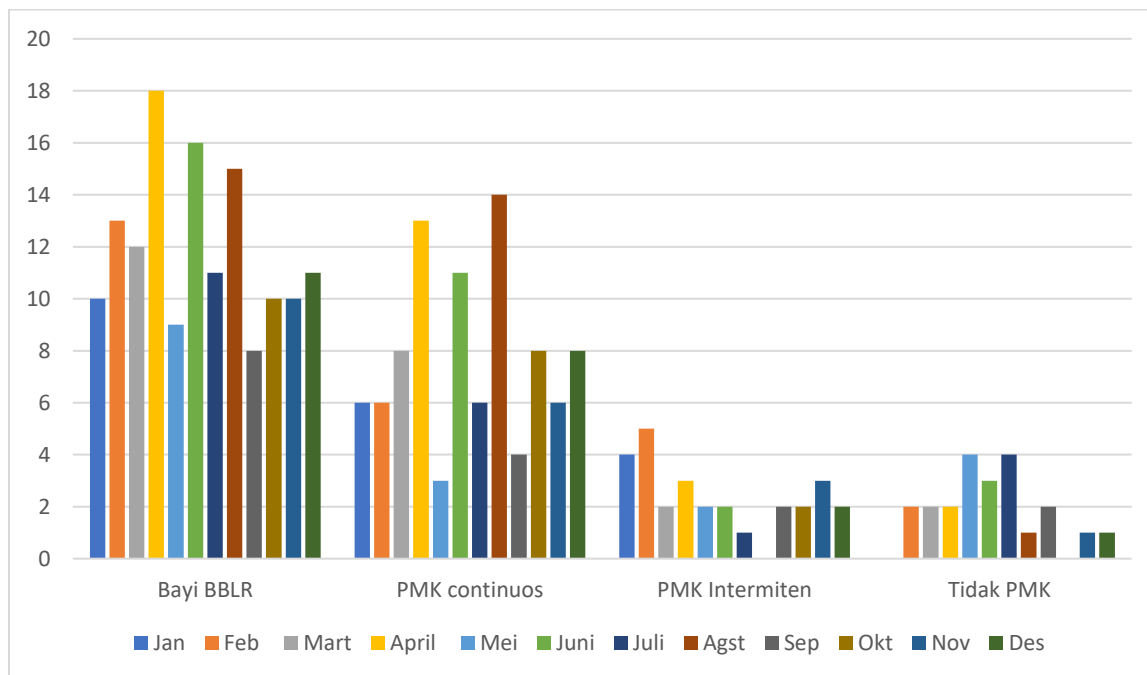
3.3.25 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel 3.3.25 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR RSPHM Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pasien												Σ 2025
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Bayi BBLR	10	13	12	18	9	16	11	15	8	10	10	11	143
2	PMK continuos	6	6	8	13	3	11	6	14	4	8	6	8	112
3	PMK Intermiten	4	5	2	3	2	2	1	0	2	2	3	2	28
4	Tidak PMK	0	2	2	2	4	3	4	1	2	0	1	1	22

Grafik 3.3.25

Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Malang Tahun 2025





3.3.26 Jumlah Pencapaian Pelayanan Perawatan Metode Kangguru Pada BBLR RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.26 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR RSPHM Tahun 2025

NO	KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN 2024		PENCAPAIAN 2025	
			JML	%	JML	%
1	Bayi BBLR	185	169	90%	143	77%
2	PMK continuos	115	105	56,7%	112	97%
3	PMK Intermiten	34	31	16,7%	28	82%
4	Tidak PMK	26	24	12,9	22	84%

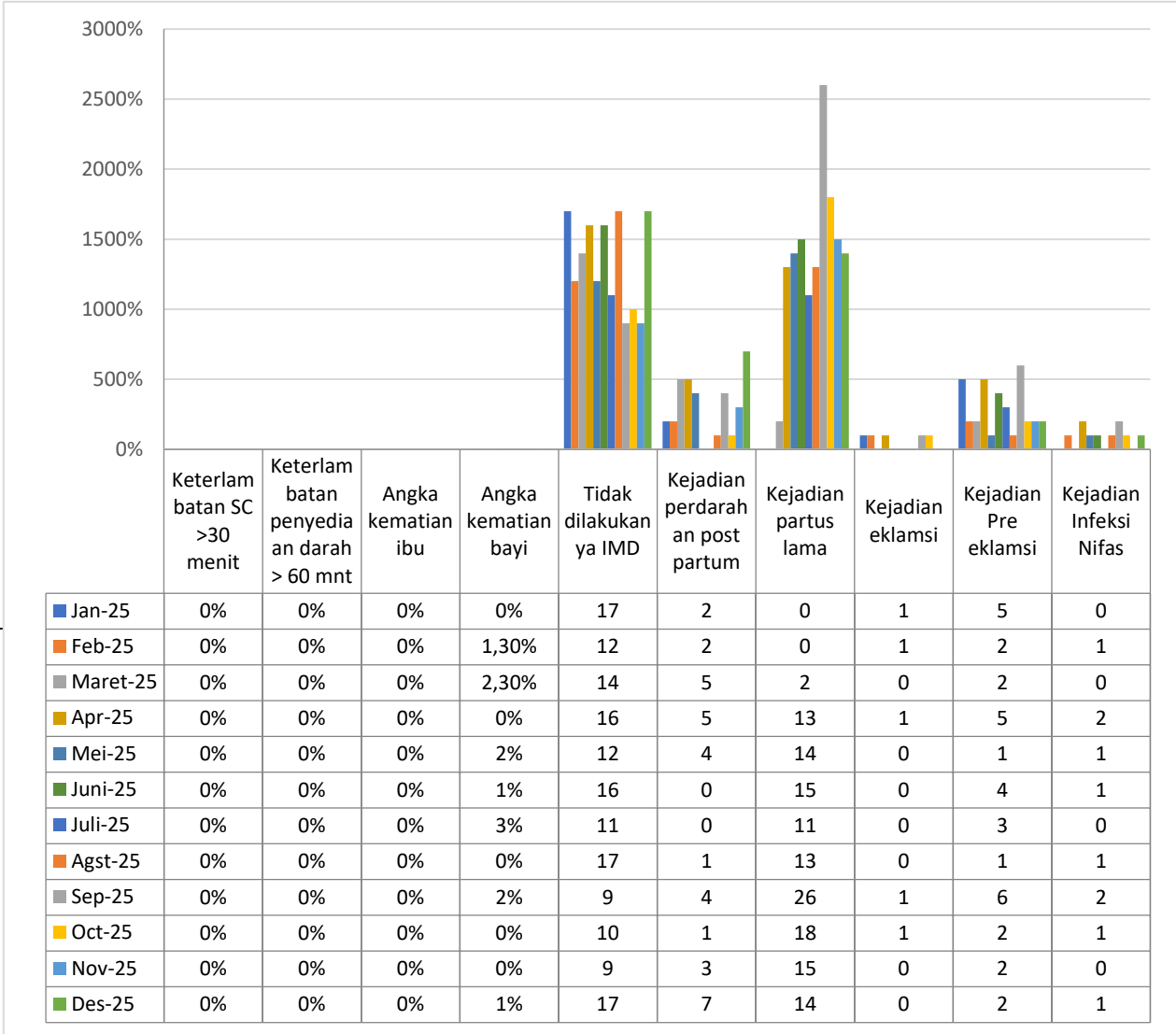
3.3.27 MUTU PONEK RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.3.27 Mutu PONEK RSPHM Tahun 2025

No	Pengukuran Mutu	Standart	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) >30 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Angka keterlambatan penyediaan darah (> 60 menit)	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Angka kematian bayi	0%	0%	1,3 %	2,3 %	0 %	2 %	1%	3 %	0 %	2%	0%	0%	1 %
5	Kejadian tidak dilakukanya IMD (Inisiasi Menyusui Dini) pada bayi baru lahir	0	17	12	14	16	12	16	11	17	9	10	9	17
6	Kejadian perdarahan post partum	0	2	2	5	5	4	0	0	1	4	1	3	7
7	Kejadian partus macet	0	0	0	2	13	14	15	11	13	26	18	15	14
8	Kejadian eklamsi	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
9	Kejadian Pre eklamsi	0	5	2	2	5	1	4	3	1	6	2	2	2
10	Kejadian Infeksi Nifas	0	0	1	0	2	1	1	0	1	2	1	0	1

Grafik 3.3.27

Mutu PONEK Di Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2025



Evaluasi

- 1) Pada Mutu Angka kematian Ibu 0%. Pada tahun 2025 tidak ada kejadian kematian pada maternal.
- 2) Pada Mutu Angka kematian Bayi tertinggi di bulan juli yaitu 3%. Hal ini yang di sebabkan karena bayi lahir imatur dan BBLASR
- 3) Pada mutu tidak dilakukannya Inisisasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir, tertinggi pada bulan januari dan agustus yaitu 17 bayi disebabkan karena BBLR dan asfiksia sedang-berat yang membutuhkan perawatan incubator dan oksigen.
- 4) Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir dikarenakan bayi lahir dengan BBLR kurang bulan dan Asfiksia, sehingga bayi memerlukan tindakan segera untuk pemasangan alat bantu CPAP dan perawatan incubator.
- 5) Pada kasus pasien pre eklamsi tertinggi pada bulan September yaitu 6 pasien. Unit terkait akan berkolaborasi dengan SP.OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi.

	6) Pada kasus Kejadian partus macet tertinggi pada bulan September yaitu 26 pasien dikarenakan prolong fase laten, prolong fase aktif, dan kala 2 lama, sehingga pasien dilakukannya operasi SC. 7) Pada kasus kejadian perdarahan post partum tertinggi pada bulan maret dan April yaitu 5 pasien disebabkan karena atonia uteri. 8) Pada kasus kejadian Infeksi nifas tertinggi pada bulan September yaitu 2 pasien disebabkan karena pasien tarak makan, kurang menjaga kebersihan.
RTL	1) Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak. 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makanan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasie dengan riwayat darah tinggi. 3) berkolaborasi dengan SP.OG dalam melakukan skrining ibu hamil yang beresiko untuk terjadi eklamsi serta mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan hipertensi 4) Memberikan Edukasi pada Ibu post Nifas terkait gizi yang dibutuhkan ibu Nifas, agar tidak terjadi lagi kasus infeksi pada Ibu nifas. 5) Mengevaluasi tiap bulan peningkatan jumlah Kunci indikator mutu PONEK. 6) Koordinasi dengan Tim PMKP untuk melakukan pelaporan dan evaluasi setiap bulan, yang nantinya akan dilaporkan ke direktur Rumah Sakit.

3.11 PKRS

Tabel 3.11 PKRS di Ponek RSPHM Tahun 2025

Kegiatan	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	K E T
Edukasi kelompok	4 x/bl	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	
Edukasi individu	100% pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
KIE MASSA : RADIO, lg, FC,	8x/bl	-	-	-	1x	-	-	-	1x	-	-	1x	-	
Pembuat an leaflet	10 Bsr Penyakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemasangan Poster banner	1. 2. 3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



BAB IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. Ketenagaan Tim Ponek Tahun 2025 belum sesuai kebutuhan unit, unit maternitas kurang 1 bidan, dan neonatologi kurang 1 perawat jika sesuai perhitungan pola ketenagaan
2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tim Ponek sudah terlaksana sesuai jadwal, yaitu diklat internal maternal terlaksana 1 kali, diklat neonatal terlaksana 2 kali, drill emergency maternal dan neonatal terlaksana 3 kali dan diklat eksternal terlaksana 1 kali dengan 2 bidan yang telah mengikuti diklat PPGDON.
3. Pembinaan jejaring dilakukan 2 kali di tahun 2025 yaitu pada bulan mei dengan materi Stabilisasi Pra Rujukan Neonatal dan oktober dengan materi Pendamping ibu hamil dengan hypnoregnancy
4. Imunisasi Hb 0 masih belum memenuhi jumlah kelahiran di RS yaitu 10,8 % dari jumlah bayi 1379 yang lahir di RS di karenakan jumlah vaksin dari dinas kesehatan yang dikirim ke puskesmas terbatas sehingga tidak bisa di berikan ke RS swasta
5. IUD pasca salin masih belum memenuhi target dikarenakan pasien terkendala biaya jika di pasang oleh dokter dan pasien ingin KB setelah nifas
6. Angka kematian bayi 0,79 % dari jumlah bayi lahir di RS faktor penyebab dikarenakan bayi lahir imatur dan BBLASR

3.2 Saran

1. Pengajuan ke SDM untuk pemenuhan kebutuhan staf PONEK di maternitas dan Neonatologi
2. Pengadaan imunisasi uvak B untuk memenuhi imunisasi bayi baru lahir
3. Menggratiskan jasa KB RS sebagai promosi persalinan lebih banyak di RS
4. Pemakaian fasilitas NICU yang sesuai standart



BAB V

PENUTUP

Demikian laporan tahun 2025 PONEK disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya

Malang, 01 Januari 2026

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Lampiran 1:

NO	Nama	Semester 1	Semester 2
1	dr. Isrotul Annisa	- Tanggap dan cekatan dalam pemeriksaan pasien - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap	- Tanggap dan cekatan dalam pemeriksaan pasien - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap
2	dr. Annishafira	- Tanggap dan cekatan dalam pemeriksaan pasien - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap	- Tanggap dan cekatan dalam pemeriksaan pasien - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap
3	Triasih Amd.Keb	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan kegawatan maternal - Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan kegawatan maternal - Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap
4	Nining Trisari Amd.Keb	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan kegawatan maternal - Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan kegawatan maternal - Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap
5	Elok Oktaviana Amd.Keb	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan kegawatan maternal - Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan kegawatan maternal - Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap



6	Leny Puji Rahayu Amd.Keb	• Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. • Mampu memberikan edukasi sesuai kebutuhan pasien	• Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. • Mampu memberikan edukasi sesuai kebutuhan pasien
7	Dwinta Widya Navita,Amd.Kep	• Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan • Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. • Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap dengan bantuan	• Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan • Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. • Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap dengan bantuan
8	Ns. Rismaya Felantiardianti, S.Kep	• Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan kegawatan Neonatal • Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. • Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap	• Tanggap dan cekatan dalam melakukan tindakan kegawatan Neonatal • Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit. • Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai Protap
9	Anita Sari S.Kep Ns	• Mampu melakukan Tindakan kegawatan dengan bantuan • Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit.	• Mampu melakukan Tindakan kegawatan dengan bantuan • Bisa mengambil keputusan saat menemui masalah di unit.